

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Refus de traitement

Conduite à tenir devant refus ponctuel ou répété d'un traitement, en conciliant sécurité, consentement et traçabilité.

Indications

- Refus explicite de prise d'un traitement.
- Opposition répétée à l'administration.
- Besoin d'évaluer les enjeux cliniques du refus.

Vérifications préalables

- Identifier traitement concerné, importance et délai critique.
- Rechercher cause du refus : douleur, dysphagie, effet secondaire, incompréhension.
- Évaluer capacité de compréhension et contexte de consentement.
- Rechercher alternatives de forme si connues.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas forcer la prise sans cadre légal/médical adapté.
- Ne pas masquer le refus dans la traçabilité.
- Ne pas écraser/modifier une forme galénique sans validation.
- Ne pas répéter une confrontation stérile.

Conduite à tenir

- Réexpliquer calmement l'intérêt du traitement.
- Proposer une nouvelle tentative différée si adapté.
- Signaler rapidement au médecin/IDE si traitement critique ou refus répétés.
- Envisager alternative galénique ou stratégie médicale après avis.

Surveillance et traçabilité

- Tracer traitement refusé, heure, motif supposé et information transmise.
- Noter nombre de refus et conséquences cliniques potentielles.
- Surveiller apparition d'effets de l'arrêt.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si refus d'un traitement à enjeu aigu ou répétition.
- Appel urgent si refus dans un contexte vital immédiat ou trouble de conscience associé.

Mention de sécurité

Le refus de traitement est un fait clinique et juridique à tracer. Objectif : compréhension et adaptation, pas contrainte réflexe.

Fait à :

Le : / /

Signature :